Biotipo, hidratación, peso e IMC

SEMIOLOGIA · Clase 09 · lo que se ve del cuerpo antes de tocarlo

1 · BIOTIPO: EL ÁNGULO DE CHARPY Y SUS ENFERMEDADES

Biotipo F1
manifestación morfológica individual; se clasifica por el ángulo de Charpy

si el ángulo es agudo → **Longilíneo · Charpy <90°** F1
alto y delgado, miembros y cuello largos, tórax estrecho
por su constitución → **En él prevalecen**
TBC, artritis reumatoide, úlcera duodenal e hipotensión

si el ángulo es recto → **Normolíneo · Charpy = 90°** F1
equilibrio entre tronco y extremidades; músculo y panículo armónicos
por su constitución → **En él prevalece**
la epilepsia

si el ángulo es obtuso → **Brevilíneo · Charpy >90°** F1
corto y pícnico, cuello corto, abdomen globuloso
por su constitución → **En él prevalecen** F1
HTA, ACV, enfermedad coronaria, gota, artrosis y várices

no equivale a obeso, pero puede sumar

2 · EL BALANCE DE AGUA: 2500 ML AL DÍA

Estado de hidratación
se valora con peso, piel, mucosas, fontanelas, ojos y estado general
el peso se compara con el → **Balance · 2500 ml/día**
entran bebida 1200 + alimentos 1000 + endógena 300; salen orina 1400 + heces 100 + insensibles 1000
si entra lo mismo que sale, hay → **Hidratación normal**
piel rosada, elástica y húmeda; mucosas húmedas; peso estable

si sale más de lo que entra, por

3 · CÓMO SE ROMPE: DESHIDRATACIÓN

Pérdidas excesivas u oferta insuficiente
diarrea, vómitos, fiebre, taquipnea o sudoración excesiva
rompen el balance y causan → **Deshidratación**
se rompe el balance hídrico; el paciente siente sed, astenia e irritabilidad

el examinador encuentra → **Lo que se ve**
peso bajo, piel y mucosas secas, ojos hundidos, hipotonía, fontanela deprimida

si repercute en la circulación → **Compromiso cardiovascular**
taquicardia, yugulares colapsadas e hipotensión postural

cuánta: se gradúa por

4 · CUÁNTA Y DE QUÉ TIPO: PESO PERDIDO Y SODIO

Por intensidad F3
se mide en la balanza el porcentaje de peso perdido

hasta 5 % → **Leve o 1.º grado** F3
hasta 5 % del peso

si pierde más de 5 % → **Moderada o 2.º grado** F3
5 a 10 % del peso

si pierde más de 10 % → **Grave o 3.º grado** F3
más de 10 % del peso

de qué tipo: se clasifica por

Por osmolaridad
se mide el sodio sérico; normal 135 a 145 mEq/L

si el sodio no cambia → **Isotónica**
sodio normal

si el sodio baja → **Hipotónica**
sodio bajo: menos de 130 mEq/L en 2020 (2018: menos de 135)

si se pierde más agua → **Hipertónica**
se pierde más agua que sodio: el sodio sube; el peso dice cuánta, el sodio de qué tipo

el peso bajo se compara con el

la piel seca se explora con el

5 · EL PLIEGUE CUTÁNEO Y SU TRAMPA EN EL ANCIANO

Signo del pliegue cutáneo F2
pellizcar la piel y ver cuánto tarda en volver

si tarda en volver indica → **Retorno lento** F2
= turgor disminuido

en la edad avanzada se toma → **En el anciano**
tomarlo en frente o esternón
porque en mano o antebrazo da → **Falso positivo**
la piel de mano y antebrazo ya es laxa por la edad

6 · PESO IDEAL E IMC: SI SOBRA O FALTA

Peso ideal de Broca
talla (cm) − 100 en kg
se corrige → **En la mujer**
se resta además otro 5 %
así el ideal femenino entra al → **Rango normal**
ideal ±10 %; ej.: varón de 1,60 m, 54 a 66 kg
fija el rango

se afina con el → **Índice de masa corporal**
peso (kg) / talla² (m): corrige el peso por la altura

si es muy bajo → **Bajo peso**
IMC menor de 18 kg/m²

si es adecuado → **Normal**
IMC 19 a 23 kg/m²

si supera 26 → **Obesidad**
IMC mayor de 26 kg/m²
si supera 40 → **Obesidad mórbida**
IMC mayor de 40 kg/m²

confirma la

equivale a la

si queda bajo el mínimo hay

7 · POR DEBAJO: DELGADEZ, CAQUEXIA Y DESNUTRICIÓN

Delgadez
peso por debajo del mínimo; constitucional (familiar) o patológica

si hay enfermedad → **Delgadez patológica**
DM, hipertiroidismo, neoplasia, TBC, anorexia o ingesta baja

si es extrema → **Caquexia** F5
pérdida de peso extrema con compromiso del estado general

si falta tejido sostenido → **Desnutrición**
peso bajo, músculo hipotrófico, poco panículo, piel seca y rugosa

si es rápida y no programada → **Pérdida significativa** F4
rápida y no programada: 10 % del peso basal en 6 meses (el banco marca 1 año)
obliga a la

aparece en → **Enfermedades consuntivas avanzadas** F5
TBC avanzada, cirrosis, neoplasia maligna, desnutrición grave o VIH
obliga a la

se gradúa con los → **Criterios de Gómez**
déficit de peso respecto al normal para edad y sexo
según el déficit → **Grados**
1.º más de 10 %, 2.º más de 25 %, 3.º más de 40 %
el grado orienta la

obliga a la → **Búsqueda etiológica**
la delgadez patológica, la pérdida significativa y la caquexia obligan a hallar la enfermedad de fondo

si supera el máximo hay

8 · POR ENCIMA: OBESIDAD Y PICKWICK

Obesidad
peso sobre el máximo normal; IMC mayor de 26

si la grasa es del tronco → **Central o androide**
grasa del tronco y abdomen; DM, HTA e infarto

si la grasa es de la cadera → **Periférica o ginecoide**
grasa en caderas; menor riesgo cardiometabólico

aprieta tórax y diafragma → **Grasa sobre tórax y diafragma** F6
el obeso hipoventila, sobre todo dormido: apnea del sueño e infecciones respiratorias
si hay hipoventilación forma el → **Síndrome de Pickwick** F6
obesidad con hipoventilación, hipoxemia e hipercapnia
por la hipoventilación produce → **Sus consecuencias** F6
somnolencia diurna y poliglobulia compensadora
puede evolucionar a → **Cor pulmonale crónico** F6
sobrecarga del ventrículo derecho: la complicación final

concepto · ejemplo · técnica · mecanismo · desenlace · causa · síndrome · signo · diagnóstico · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Sotomayor, apuntes de Semiología Médica, 2020, tema 5 (clases 05b y 05c); = literatura